

RESUMO DE ALTA HOSPITALAR

Date (auto): 2026-03-18

Document ID: healthclarify-ips-pt-01

DADOS DO PACIENTE

Nome João Manuel Silva
Idade 64
Género male

ALERGIAS

- Penicilina - erupção cutânea maculopapular difusa (documentada 2018)

HISTÓRIA CLÍNICA

- Hipertenso conhecido há 5 anos em monoterapia; controlo tensional subótimo nos últimos 12 meses.
- Diabetes mellitus tipo 2 diagnosticado há 8 anos; sob metformina 1000 mg BID.
- Fumador ativo (~30 maços-ano); recusou cessação anteriormente.
- Sem antecedentes de enfarte do miocárdio, AVC ou doença renal crónica.
- Pai falecido por morte súbita cardíaca aos 60 anos.

VALORES LABORATORIAIS NA ALTA

- Troponin I.cardiac [Mass/volume] in Serum or Plasma: 14200 ng/L (< 14)
- Cholesterol [Mass/volume] in Serum or Plasma: 245 mg/dL (< 200)
- Cholesterol in LDL [Mass/volume] in Serum or Plasma: 160 mg/dL (< 100)
- Cholesterol in HDL [Mass/volume] in Serum or Plasma: 32 mg/dL (> 40)
- Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood: 7.8 % (< 6,5)
- Creatinine [Mass/volume] in Serum or Plasma: 1.1 mg/dL (0,6-1,2)
- Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted: 68 mL/min/1,73m² (> 60)
- Left ventricular Ejection fraction: 45 % (> 55)

DIAGNÓSTICO DE ADMISSÃO

Enfarte agudo do miocárdio transmural anterior com elevação do segmento ST (STEMI)

DIAGNÓSTICOS SECUNDÁRIOS

- Hipertensão arterial essencial
- Diabetes mellitus tipo 2 sem complicações
- Hiperlipidemia mista
- Perturbação por uso de tabaco (fumador ativo, ~30 maços-ano)
- História familiar de doença arterial coronária prematura

PROCEDIMENTOS REALIZADOS

- Intervenção coronária percutânea (ICP) primária por via radial direita
- Implantação de stent farmacológico (DES) na artéria descendente anterior esquerda (DA) proximal
- Fluxo TIMI 3 restaurado após ICP
- Terapia antiagregante plaquetária dupla (DAPT) iniciada (aspirina + ticagrelor)
- Reabilitação cardíaca Fase I iniciada antes da alta

NARRATIVA CLÍNICA

Doente do sexo masculino, 64 anos, fumador, com hipertensão e diabetes tipo 2, admitido no Serviço de

RESUMO DE ALTA HOSPITALAR

Urgência por dor torácica retroesternal intensa com irradiação ao membro superior esquerdo, diaforese e dispneia progressiva em esforço mínimo, com cerca de 90 minutos de evolução. O ECG revelou elevação do segmento ST ≥ 2 mm nas derivações V1-V4, compatível com enfarte agudo do miocárdio anterior com supradesnivelamento ST (STEMI). O doente foi transportado de emergência para o laboratório de hemodinâmica. A coronariografia revelou oclusão trombótica de 95% da artéria descendente anterior esquerda (DA) proximal. Foi implantado com sucesso um stent farmacológico, restaurando fluxo TIMI 3. O pico de troponina I de alta sensibilidade atingiu 14.200 ng/L. O ecocardiograma transtorácico pós-procedimento revelou fração de ejeção ventricular esquerda ligeiramente reduzida (45%) com hipocinesia da parede anterior e do septo interventricular. A dupla terapêutica antiagregante foi mantida. O doente permaneceu hemodinamicamente estável, sem recorrência de dor torácica ou arritmias, tendo alta hospitalar com follow-up cardiológico estruturado e integração no programa de reabilitação cardíaca.

MEDICAÇÃO À ALTA

Medicamento	Dose	Finalidade	Horário
Acetylsalicylic acid	100 mg por dia	Antiagregante - previne coágulos sanguíneos	Manhã
Ticagrelor	90 mg duas vezes ao dia	Antiagregante - protege o novo stent	Manhã e noite
Atorvastatin	80 mg por dia	Reduz o colesterol e estabiliza as placas	Ao deitar
Ramipril	2,5 mg por dia	Protege o coração e reduz a pressão arterial	Manhã
Metoprolol	25 mg por dia	Reduz a frequência cardíaca e protege o coração	Manhã
Metformin	1000 mg duas vezes ao dia	Continuação do tratamento da diabetes	Manhã e noite

INSTRUÇÕES DE SEGUIMENTO

Consulta externa de cardiologia em 14 dias. Registo diário da pressão arterial no domicílio. Consulta de cessação tabágica em 7 dias. Reabilitação cardíaca Fase II com início em 3 semanas. Repetir perfil lipídico, HbA1c e função renal em 3 meses.

SINTOMAS DE ALERTA — LIGAR 112 SE:

- ! Dor ou pressão torácica recorrente com duração superior a 5 minutos
- ! Falta de ar em repouso ou agravamento noturno
- ! Tonturas súbitas, desmaio ou pré-síncope
- ! Inchaço súbito dos tornozelos ou pernas
- ! Hemorragia que não para em 10 minutos (sob terapêutica antiagregante)
- ! Qualquer novo sintoma neurológico (fraqueza, fala arrastada, perda de visão)

RESUMO DE ALTA HOSPITALAR

Documento sintético e anonimizado gerado para demonstração do HealthClarify. Não é um registo médico real.